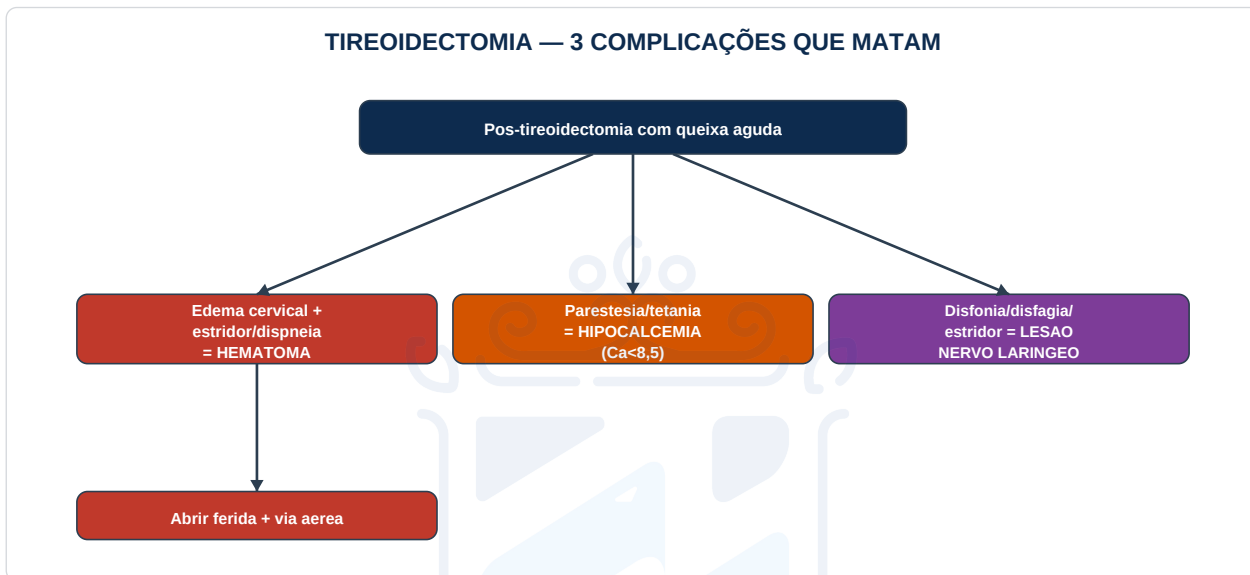


## COMPLICAÇÕES AGUDAS PÓS-TIREOIDECTOMIA

### FLUXOGRAMA — PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO



### 1) HEMATOMA CERVICAL — RED FLAG

#### PERÍODO CRÍTICO: PRIMEIRAS 6 HORAS

- Precoces: piora da dor cervical, assimetria do pescoço, mudança na saída do dreno, tensão cervical
- Tardios (via aérea): disfagia, mudança na voz, ESTRIDOR, dispneia/taquipneia, edema facial/língua, desvio traqueal, agitação
- É emergência: o hematoma comprime a via aérea por obstrução venosa/linfática (edema laríngeo), não só por compressão direta
- CONDUTA: evacuação IMEDIATA dos coágulos à beira-leito se desconforto respiratório importante (abrir a ferida)
- Avaliar necessidade de IOT/traqueostomia; depois levar ao centro cirúrgico para reabordagem (hemostasia)

### HEMATOMA — CONDUTA NO PS

#### Rx PASSO A PASSO

1. Chamar ajuda (cirurgia/anestesia) e preparar via aérea difícil
2. Se desconforto respiratório importante / edema de mucosa laríngea: ABRIR a ferida e evacuar coágulos à beira-leito
3. Reavaliar via aérea: IOT precoce; se falhar/inviável -> cricotireoidostomia/traqueostomia
4. Quadros sem repercussão grave: encaminhar ao centro cirúrgico para reabordagem
5. Monitorização contínua, O2, acesso e suporte

## 2) HIPOCALCEMIA — QUANDO SUSPEITAR

### POR LESÃO/RESSECÇÃO DAS PARATIREOIDES

- Geralmente TRANSITÓRIA; sintomas iniciam em região perioral e ponta dos dedos
- Parestesia, câimbras, dormência, espasmos e rigidez muscular
- Grave: tetania, laringoespasma, convulsões
- Sinal de Trousseau (espasmo carpopedal ao insuflar o manguito) e Chvostek (contração facial à percussão do facial)
- ECG: prolongamento do QT -> risco de Torsades de Pointes
- Diagnóstico: clínico + Cálcio < 8,5 mg/dL (considerar dosagem 4-6h pós-op para flagrar assintomático)

## HIPOCALCEMIA — TRATAMENTO (não esperar laboratório)

### Rx LEVE / POUCO SINTOMÁTICO (Ca 7,5-8,5)

Carbonato de cálcio 500mg VO 8/8h (longe das refeições)  
Se sem melhora com VO:  
Gluconato de cálcio 10% 10mL + SF 50mL EV em BIC, correr em 30 min  
Reavaliar sintomas e cálcio seriado

### Rx GRAVE / SINTOMÁTICO (Ca < 7,5)

Gluconato de cálcio 10% 20mL + SF 50mL EV em BIC, correr em 20 min  
Eleva o cálcio por apenas 2-3h -> MANTER infusão  
Manter até regime oral efetivo de cálcio (± calcitriol)  
Não aguardar o laboratório para iniciar a reposição  
Monitorizar ECG (QT) durante a reposição

## 3) LESÃO DO NERVO LARÍNGEO RECORRENTE (INFERIOR)

| Padrão                        | Voz / sintomas                          | Via aérea        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Unilateral, paralisia mediana | Pode não ter disfonia; sem disfagia     | Preservada       |
| Unilateral, paralisia lateral | Piora da voz, disfagia, broncoaspiração | Geralmente ok    |
| Bilateral, paralisia lateral  | Voz ruim, disfagia, broncoaspiração     | Respiração 'boa' |
| Bilateral, paralisia mediana  | Dispneia importante                     | TRAQUEOSTOMIA    |

## LESÃO DO NERVO LARÍNGEO SUPERIOR

### RAMOS

- Ramo externo: dificuldade para emitir sons agudos (perda da projeção/voz aguda)
- Ramo interno: engasgos frequentes (perda da sensibilidade supraglótica)
- Lesão bilateral do recorrente em paralisia mediana = dispneia grave -> indicação de traqueostomia
- Documentar a voz e a deglutição; encaminhar à cirurgia de cabeça e pescoço/ORL

## CHECKLIST DE AVALIAÇÃO PÓS-OP

### NÃO ESQUECER

- ☐ Inspeção/palpação cervical e do dreno (hematoma) nas primeiras 6h
- ☐ Pesquisar parestesia perioral/dedos e sinais de Chvostek/Trousseau (hipocalcemia)
- ☐ Avaliar voz, deglutição e ruído respiratório (lesão de nervo laríngeo)
- ☐ Cálcio e ECG (QT) se sintomas; iniciar reposição sem aguardar laboratório se sintomático
- ☐ Hematoma com desconforto respiratório = abrir a ferida JÁ

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente em pós-operatório de tireoidectomia (\_\_\_h) com \_\_\_ (hematoma cervical / hipocalcemia / disfonia-estridor).
- Via aérea: \_\_\_ (pérvia / IOT / traqueostomia). Cálcio: \_\_\_; reposição iniciada: sim/não.
- Hematoma evacuado à beira-leito: sim/não. Conduta atual: \_\_\_.
- Solicito reabordagem cirúrgica / vaga / avaliação de cirurgia de cabeça e pescoço.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente 4 horas após tireoidectomia total apresenta abaulamento cervical tenso, disfagia, voz alterada e estridor. Qual a conduta IMEDIATA?

- A) Solicitar TC de pescoço e aguardar resultado
- B) Abrir a ferida cervical à beira-leito para evacuar o hematoma e assegurar a via aérea
- C) Administrar corticoide e observar
- D) Repor cálcio endovenoso
- E) Encaminhar para fonoaudiologia

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente pós-tireoidectomia com parestesia perioral e nas pontas dos dedos, sinal de Chvostek positivo. Qual a conduta?

- A) Aguardar o cálcio sérico antes de qualquer medida
- B) Iniciar reposição de cálcio (VO ou EV conforme gravidade) sem aguardar o laboratório
- C) Administrar bicarbonato
- D) Iniciar antibiótico
- E) Repor potássio

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual lesão nervosa pós-tireoidectomia tipicamente exige traqueostomia por dispneia importante?

- A) Lesão unilateral do nervo laríngeo recorrente em posição mediana
- B) Lesão BILATERAL do nervo laríngeo recorrente em paralisia mediana
- C) Lesão do ramo externo do laríngeo superior
- D) Lesão do ramo interno do laríngeo superior
- E) Lesão isolada do nervo hipoglosso

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a hipocalcemia pós-tireoidectomia, é correto afirmar:

- A) É sempre permanente
- B) Decorre de lesão/ressecção das paratireoides, é frequentemente transitória e pode prolongar o intervalo QT
- C) Não causa sintomas neuromusculares
- D) Nunca causa arritmia
- E) Dispensa monitorização eletrocardiográfica

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o período mais crítico para o hematoma cervical pós-tireoidectomia?

- A) Após 30 dias
- B) Primeiras 6 horas
- C) Entre o 7o e o 14o dia
- D) Apenas durante a cirurgia
- E) Após 72 horas

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hematoma cervical expansivo com estridor é emergência de via aérea: abre-se a ferida à beira-leito para descompressão imediata e garante-se a via aérea (IOT precoce; traqueostomia se falhar). Imagem não deve atrasar a descompressão.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Hipocalcemia sintomática pós-tireoidectomia deve ser tratada de imediato (VO se leve, gluconato de cálcio EV se grave), sem aguardar o laboratório. O cálcio confirma ( $<8,5$ ) mas não deve atrasar a reposição.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

A lesão BILATERAL do nervo laríngeo recorrente com cordas em posição mediana fecha a via aérea, causando dispneia importante e exigindo traqueostomia. As unilaterais costumam preservar a respiração.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipocalcemia decorre de lesão/ressecção das paratireoides, é em geral transitória, cursa com sintomas neuromusculares (Chvostek/Trousseau) e prolonga o QT, predispondo a Torsades — exige monitorização.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

As primeiras 6 horas são o período crítico do hematoma cervical pós-tireoidectomia, quando o risco de expansão e obstrução de via aérea é maior — justificando observação rigorosa nesse intervalo.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico